

SH.GSR.02.ICD.18			رقم السياسة
الأوامر الشفهية والتليفونية			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١٠	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الأقسام الاكلينيكية ب المستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- تنص سياسة المستشفى على استخدام الأوامر الشفهية يقتصر في الحالات الطبية الطارئة.
- يمكن قبول الأوامر الشفهية والتليفونية من قبل ممرضة مسجلة في ظروف محدودة عندما يكون من المستحيل أو غير العملي أن يكتبها الطبيب (يقوم الطبيب بإجراء عالي الخطورة وعند تأخر الأمر ينتج عنه تعرض المريض للخطر على أن يكون ذلك في أضيق الحدود لتيسير الرعاية الطبية المقدمة لذلك).
- يتم توثيق الأوامر الشفهية والتليفونية من قبل المتلقي
- يتم قراءة الأوامر الشفهية والتليفونية من قبل المتلقي للتأكيد، يتم تأكيد الأمر من قبل الطبيب المعالج
- تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين في المستشفيات المشاركين في الرعاية الصحية بما في ذلك الأطباء والمرضات وفنيو المختبرات أو الأشعة.

الغرض

- التقليل من الأخطاء المرتبطة بالتفسير الخاطئ الأوامر الشفهية والتليفونية ونتائج الاختبار (المعامل والأشعة).
- توفير التوجيه للأطباء والتمريض في الممارسة الآمنة للطلبات الشفهية والتليفونية المقدمة في حالات الطوارئ فقط بما يحقق سلامة المرضى

التعريفات

- الأوامر الشفهية: هي أوامر تعطي شفها بين مقدمي الرعاية الطبية وتكون في الحالات الطارئة لإنقاذ حياة مريض ويتواجد فيها مصدر الأمر الشفهي مع متلقي الأمر الشفهي
- الأوامر التليفونية: هي أوامر تعطي عبر الهاتف بين مقدمي الرعاية الطبية وتكون في الحالة الطارئة لإنقاذ مريض

إجراءات العمل

- (١) الحالات التي يسمح ب الأوامر التليفونية:
 - ❖ عند إبلاغ النتائج الحرجة (المعمل –الأشعة)
 - ❖ تواجد الطبيب في قسم الطوارئ لمناظرة حالة طارئة (الحوادث، ...)
 - ❖ في حالة استدعاء فريق التدخل السريع RRT فريق الإنعاش القلبي الرئوي CODE BLUE

❖ حالة أن يكون الطبيب يؤدي إجراء عالي التطهير أو متعقم

- ❖ في حالة عدم وضوح اختصار مكتوب بأحد نماذج الملف الطبي أو كتابة اختصار ممنوع (راجع سياسة استخدام الاختصارات والرموز الطبية)
- ❖ يتم قبول الطلبات التليفونية فقط عندما يكون الأطباء الأساسيون غير متاحين لكتابة الطلب (مشغول في الحالات العاجلة أو في OR) والتأخير سيضعف رعاية المرضى.

٢) الأوامر شفوية:

- ❖ لا يُسمح بالأوامر الشفوية المباشرة عندما يكون الطبيب موجودًا ويكون سجل المريض متاحًا إلا أثناء إجراء معقم أو في حالات الطوارئ وفي هذه الحالة يكون التكرار مقبولاً.
- ❖ يجب قبول الطلبات الشفهية المباشرة فقط من الطبيب المعالج ويجب أن تكون الأوامر مناسبة وفي نطاق الممارسة المهنية.
- ❖ يتم قبول الطلب الشفهي المباشر في حالة التغيير الطارئ في حالة المريض التي تتطلب تغييرًا فوريًا في وتيرة أو معدل ضخ الأدوية المطبقة بالفعل على المريض.
- ❖ الطبيب المعالج يعطي الترتيب اللفظي بشكل واضح.
- ❖ يجب على الممرضة المستقبلية تكرار الأمر الشفهي مرة أخرى على الطبيب المعالج والطبيب الذي يعطي الأمر شفويًا يؤكد أن الأمر المكرر صحيح.
- ❖ لا يُسمح للممرضات بالحصول على أمر دوائي جديد شفهيًا
- ❖ طلب شفهي مباشر أو طلب علاج شفهي خلال الكود بلو:

■ يعطي الطبيب المعالج أمر إعطاء العلاج بشكل واضح.

■ تكرر الممرضة المستلمة الطلب وتتلقى تأكيدًا من الطبيب المعالج

■ يتم توثيق هذه الأوامر في نموذج الكود بلو وفقًا لسياسة الكود بلو

- ❖ يمكن أيضا قبول الأوامر الشفوية مباشرة في إجراءات معقمة مثل المناظير، المنظار الرئوي والبزل القطني.

- ❖ ستقوم الممرضة المستلمة بكتابة ثم إعادة قراءة الأمر الشفوي مرة أخرى إلى الطبيب المعالج والطبيب الذي يعطي الأمر شفويًا يؤكد أن الأمر المكرر صحيح.

- ٣) لا يُسمح بالأوامر الشفهية والتليفونية إلا في الحالات الأكثر إلحاحًا حيث يتعذر على الطبيب المعني كتابة الأمر أو يكون الدواء مطلوبًا للمريض في حاجة عاجلة وغير مخططة (طبيب يتعامل مع حالة توقف قلبي رئوي)

٤) يمنع قبول الأوامر الشفهية أو الهاتفية في الحالات الآتية

- ❖ منتجات الدم/الدم (قد تحدث في حجرة العمليات أو الطوارئ في حالات الطوارئ).
- ❖ العلاج الكيميائي.
- ❖ المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة.
- ❖ أطفال /حديثي الولادة.
- ❖ المرضى الذين يعانون من مرض كلوي.
- ❖ الإجهاض والأدوية التي تحفز الولادة.
- ❖ التغذية الوريدية.
- ❖ أمر التقييد

٥) يتم قبول الامر الشفهي من الطبيب المعالج القائم على الحالة فقط

٦) داخل العمليات يتم تسجيل الأوامر الشفهية في نماذج العمليات

٧) أوامر الدواء عبر التليفون

❖ تقوم الممرضة المسؤولة بالاتصال بالطبيب المعالج، ويجب أن تقدم المعلومات التالية للطبيب:

■ تحديد المريض (اسم المريض، الرقم الموحد).

■ تشخيص المريض.

■ نبذة عن تاريخ المريض (الحساسية، الادوية التي يخضع لها المريض، جميع المعلومات ذات الصلة).

■ شرح حالة المريض.

❖ يجب على الممرضة أن تكتب على الفور الدواء وجميع توصيات الطبيب في نموذج الأوامر الشفهية و تسجيله في ملف المريض الطبي.

❖ تقوم الممرضة بإعادة قراءة الترتيب على الطبيب المعالج والطبيب معطى الأمر يؤكد صحة ترتيب القراءة.

❖ نموذج طلب الدواء عبر التليفون يشمل:

- اسم المريض.
- اسم الملف الطبي
- اسم الطبيب
- اسم الدواء.
- شكل جرعات.
- التركيز.
- الجرعة.
- طريقة الإعطاء.
- وقت الإعطاء.
- تاريخ/ وقت تلقي الأمر.
- اسم وتوقيع الممرضة التي تلقت الأمر

❖ يمكن وصف جرعة واحدة فقط من الدواء بناءً على طلب الدواء عبر التليفون

❖ يمكن صرف جرعة علاج واحدة فقط على نموذج الأوامر الشفهية وتوثيق الصرف على النموذج

- ❖ يجب تجنب الاختصارات عند تقديم أو استلام أمر.
- ❖ سيقوم الطبيب معطى الأمر بتوضيح اسم أي أدوية غير مألوفة، إذا شعر أي من الطرفين أن ذلك ضروري.
- ❖ يجب التوقيع على نموذج طلب الدواء عبر التليفون في السجل الطبي للمريض في أقرب وقت ممكن من قبل الطبيب في نوبة عمله/ عملها وبعد أقصى ٢٤ ساعة.
- ❖ يجب أن يسجل وقت أمر الدواء الذي طلبه الطبيب في نموذج طلب الدواء عبر التليفون.

٨) أوامر الفحوصات التليفونية:

- ❖ تقوم الممرضة المسؤولة باستدعاء الطبيب المسئول عن الحالة، ويجب أن تقدم المعلومات التالية للطبيب:
 - ❖ تحديد المريض (اسم المريض، رقم الموحد).
 - ❖ تشخيص المريض.
 - ❖ نبذة عن تاريخ المريض (الحساسية، الادوية التي يخضع لها المريض، جميع المعلومات ذات الصلة).
 - ❖ شرح حالة المريض.
 - ❖ يجب على الممرضة أن تكتب على الفور الطلب في نموذج الطلب الشفهي/ التليفوني.
 - ❖ تقوم الممرضة بإعادة قراءة الأمر على الطبيب معطى الأمر والطبيب يؤكد على أن إعادة قراءة الأمر صحيحة.
 - ❖ يجب توثيق المعلومات التالية من قبل الممرضة:
 - التاريخ والوقت.
 - اسم الطبيب.
 - الأمر المعطى من قبل الطبيب.
 - سبب إعطاء الأمر شفهي.
 - تاريخ ووقت تنفيذ الأمر (بواسطة الممرضة).
- ٩) يقوم الطبيب بالتوقيع على نموذج الأوامر الشفهية او نموذج الكود بلو في أسرع وقت ممكن خلال نفس الشيفت وبعد أقصى قبل انتهاء الشيفت

المسؤول عن التنفيذ

- ❖ فنيي المعمل
- ❖ التمريض

- ❖ الأطباء
- ❖ الصيادلة

المراقبة والتقييم

- KPI: يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بمتابعة وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعملية الأوامر الشفهية والهاتفية.
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية الأوامر الشفهية والهاتفية .

النماذج / المرفقات

- نموذج تلقي الأوامر الشفهية والتليفونية
- نموذج RRT (كبار واطفال)
- النتائج الحرجة
- نموذج الإنعاش القلبي الرئوي CPR.
- معايير ذات صلة

ICD.19 Critical results; ACT.08 Handover communication

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار ٢٠٢٥. (معييار ICD.18).

[illegible]



الهيئة العامة للتأمين الصحي

فرع :

مستشفى :

Nursing Supervisor Notes:

.....

.....

.....

.....

Team Leader Report:

.....

.....

.....

.....

Return of spontaneous circulation (ROSC): Yes: ☐ Transferred to:..... at (Time):.....

No: ☐ Time of death:

Team Members	Names	Signature
Team Leader		
Primary Physician		
Nursing Supervisor		
Assigned Nurse		

MR . Code . Blue 2-2



اسم المريض:.....
رقم الملف الطبي للمريض:.....
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى :

Rapid Response Team نموذج تقرير فريق التدخل السريع

الشخص الذي استدعي الفريق:	المكان:	التاريخ:	وقت الاكتشاف	وقت الاستدعاء	وقت الوصول																				
.....		 /																							
العلامات الحيوية قبل استدعاء الفريق (خلال آخر ٦ ساعات)																									
Temperature	RR	HR	BP	Time	Date																				
.....																									
أسباب الاتصال بفريق RRT:																									
☐ معدل ضربات القلب (أكثر من ١٣٠ أو أقل من ٤٠) أو تغيير جديد في نظم القلب ☐ ضغط الدم الانقباضي (أكثر من ٢٢٠ أو أقل من ٩٠) ☐ معدل التنفس (أكثر من ٢٥ أو أقل من ٨) ☐ تغيير مفاجئ في درجة الوعي ☐ تشنجات جديدة أو غير متوقعة ☐ نزيف حاد ☐ اختناق ☐ درجة الحرارة أقل من ٣٥ درجة أو أكبر من ٣٩,١ درجة ☐ أخرى:																									
Assessment: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية)			Patient History: (يملأ بواسطة الطبيب المعالج)																						
.....																									
Intervention/Investigation: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية) needed			Patient follow up within (4 hrs) of RRT activation: Follow up (4 hrs.):																						
.....																									
Medication / (يملأ بواسطة طبيب الرعاية) supplies:			Vital Signs (يملأ بواسطة ممرض العناية):																						
.....			<table border="1"> <tr> <th>Time</th> <th>BP</th> <th>HR</th> <th>RR</th> <th>Temp.</th> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>			Time	BP	HR	RR	Temp.															
Time	BP	HR	RR	Temp.																					
.....																									
.....																									
.....																									
Outcome: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية)			Recommendation: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية)																						
☐ Stay at the room ☐ Transfer to ICU ☐ Transfer to OR ☐ Activate Code Blue team			طبيب الرعاية: طبيب الحالة: ممرض العناية: ممرضة الحالة:																						

يتم عمل نسختين (اصل + صورة) الأصل تحفظ بملف المريض والنسخة الاخرى يقوم مشرف القسم بتسليمها الى قسم الجودة.

MR.Inp.Dr.1-2



اسم المريض:.....
رقم الملف الطبي للمريض:.....
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى :

(Pediatric Rapid Response Team Report)

نموذج تقرير فريق التدخل السريع للأطفال

وقت الوصول	وقت الاستدعاء	وقت الاكتشاف	التاريخ: / /	المكان:	الشخص الذي استدعى الفريق:																	
العلامات الحيوية قبل استدعاء الفريق (خلال آخر ٦ ساعات)																						
Date	Time	BP	HR	RR	Temperature																	
Normal vital signs according to age																						
Age Group	Preterm	Newborn (0 to 1 Month)	Infant (1 to 12 Month)	Toddler (1 to 3 Years)	Preschool (3 to 6 Years)	School Age (6 to 12 Years)	Adolescents (12+ Years)															
Respirations	50-70	35-55	30-40	20-30	20-30	18-24	14-22															
Heart Rate	120-180	100-160	80-140	80-130	80-110	70-100	60-90															
Systolic BP	40-60	50-70	70-100	70-110	80-110	80-120	100-120															
أسباب الاتصال بفريق RRT : ☐ تغيير مفاجئ في درجة الوعي ☐ تشنجات جديدة أو غير متوقعة ☐ نزيف حاد ☐ اختناق ☐ درجة الحرارة أقل من ٣٥ درجة أو أكبر من ٣٨,٥ درجة ☐ أخرى:																						
Patient History: (يملأ بواسطة الطبيب المعالج)				Assessment: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية)																		
Patient follow up within (4 hrs) of RRT activation: Follow up (4 hrs.):				Intervention/Investigation : (يملأ بواسطة طبيب الرعاية) needed																		
Vital Signs : (يملأ بواسطة ممرض العناية) <table border="1"> <tr> <th>Time</th> <th>BP</th> <th>HR</th> <th>RR</th> <th>Temp.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Time	BP	HR	RR	Temp.											Medication / (يملأ بواسطة طبيب الرعاية): supplies:			
Time	BP	HR	RR	Temp.																		
Outcome: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية) ☐ Stay at the room ☐ Transfer to ICU ☐ Transfer to OR ☐ Activate Code Blue team				Recommendation: (يملأ بواسطة طبيب الرعاية)																		
الطبيب المعالج: طبيب الحالة: ممرض العناية: ممرضة الحالة:																						

يتم عمل نسختين (اصل + صورة) الأصل تحفظ بملف المريض والنسخة الاخرى يقوم مشرف القسم بتسليمها الى قسم الجودة.

MR.Inp.Dr.1-2

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع :
 مستشفى :

اسم المريض :
 رقم الملف الطبي :
 القسم المعالج :



نموذج تلقى الاوامر الشفهية والتليفونية
receiving verbal and Telephone order form
الحالات التي لا يسمح فيها بالاوامر التليفونية (Cases where Telephone orders are not permitted)

١ - نقل الدم ومشتقاته . ٢ - اعطاء ادوية المخدرات . ٣ - العلاج الكيماوي . ٤ - الادوية التي تسبب الاجهاض .
 ٥ - اطفال / حديثي الولادة . ٦ - المرضى الذين يعانون من مرض كلوي . ٧ - التغذية الوريدية .

1- Blood transfusion and one of its derivatives . 2- Giving drugs . 3- Chemotherapy . 4- Drugs that cause abortion .
 5- Children / Neonates . 6- Patients With significant renal disease . 7- Total Parenteral nutrition .

التاريخ	الوقت	اسم الدواء / التركيز	الجرعة	طريقة الاعطاء	تعليمات الاعطاء	اسم المتلقي	اعاده الاوامر	توقيع بعد	وقت التنفيذ	اسم الطبيب	توقيع الطبيب
Date	Time	Drug name concentration	Dose	Route	Directions	Receiving Nurse	Read back	Signature	Time of Adm	Doctor Name	Signature

MR.BL.rec. 1-1

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع :
 مستشفى :

نموذج التبليغ عن النتائج الحرجة

التاريخ	اسم المريض	رقم الملف الطبي	اسم التحليل / الفحص	وقت النتيجة	النتيجة الحرجة	اسم المبلغ	اسم الذي تم ابلاغه	الوحدة التي تم ابلاغها	وقت التبليغ
Date	Patient Name	MRN	Test Name	Result Time	Critical Result	Reported	Receiving Name	Unit Reported	Reporting Time

MR.BL.rec. 1-1